

ICW® WUNDEXPERTE — INFORMATIONSSAMMLUNG & DOKUMENTATIONSVORLAGE

MUSTER-ERFASSUNGSBOGEN FÜR HOSPITATIONSBERICHT & FALLARBEIT (UNVOLLSTÄNDIG BEISPIELHAFT / GUIDELINE TEMPLATE)

1. STAMMDATEN & HOSPITATIONSRAHMEN

Hospitant / Erfasser:

[Hier eintragen: Name, Vorname, Berufsbezeichnung (z. B. Pflegefachmann / Gesundheits- und Krankenpfleger), Kurs-Nummer & Schulungszentrum]

Hospitationsstelle:

[Hier eintragen: Name der Einrichtung, Interdisziplinäres Wundzentrum / Klinik / Pflegedienst, Standort, Betreuer & Fachliche Leitung]

Patient / Klient (DSGVO-Anonymisiert):

[Hier eintragen: Anonymisierter Code / Kürzel (z.B. Frau M. K.), Geburtsdatum / Alter, Geschlecht, Pflegegrad, Wohnumfeld (Häuslich / Pflegeheim)]

Versorgungsrahmen & Schnittstellen:

[Hier dokumentieren: Beteiligte Akteure (z. B. Pflegedienst, Hausarzt/Facharzt, Wundzentrum, Sanitätshaus, pflegende Angehörige)]

2. GESAMTANAMNESE & KAUSALE GEFÄSSDIAGNOSTIK

Hauptdiagnose & Wundursache:

[Hier dokumentieren: Exakte Ätiologie (z. B. Ulcus cruris venosum / arteriosum / mixtum, Diabetisches Fußsyndrom DFS, Dekubitus Kat. I-IV, Trauma, Postoperativ). ICD-10 & CEAP/Widmer-Stadien angeben]

Kausale Gefäßdiagnostik (ABI / Pulskontrolle):

[Zwingend dokumentieren: Knöchel-Arm-Index (ABI/Doppler-Werte Re/Li). Wichtig: ABI 0,8–1,3 = Kompression indiziert; ABI <0,8 = Kardiologische/Gefäßchirurgische Abklärung; ABI <0,5 = Kompression KONTRAINDIZIERT!]

Nebendiagnosen & Risikofaktoren:

[Hier erfassen: Relevante Grunderkrankungen (Diabetes mellitus, HbA1c, PAVK, Art. Hypertonie, CVI, Adipositas, Malnutrition, Rauchen, Immobilität, Bisherige Medikation)]

Bisherige Wundhistorie & Stagnation:

[Hier beschreiben: Bestehensdauer der Wundsituation (z. B. seit X Monaten), bisher angewendete Verbandsstoffe, Ursachen der bisherigen Therapiefehler / Wundheilungsstagnation]

3. STRUKTURIERTE WUNDBESCHREIBUNG (INITIALBEFUND / WOCHE 1)

Wundlokalisierung:

[Exakte anatomische Lage angeben: z. B. Malleolus medialis sinister, Sakrum, Fersenecke re.]

Wundgeometrie & Tiefe:

[Länge × Breite (in cm), errechnete Wundfläche (in cm²), Tiefe (in mm), Unterminierungen / Taschen (in cm & Uhrzeit)]

Wundgrund (M.O.I.S.T.):

[Prozentual dokumentieren: % Nekrose (schwarz/braun), % Fibrin/Biofilm (gelb), % Granulation (rot), % Epithelisation (rosa)]

Exsudatverhalten:

[Menge: keines / leicht / mäßig / stark. Art/Farbe: serös, blutig, eitrig, fibrinos. Geruch: geruchlos / feSide / fötid]

Wundrand & Wundumgebung:

[Wundrand: glatt, rosa, mazeriert, gequollen, eingerollt, hyperkeratotisch. Wundumgebung: Erythem, Ekzem, Stauungsdermatitis, Induration, Ödem]

Schmerzerfassung (DNQP):

[Schmerzmessung nach NRS / VRS / BESD:
• Schmerz in Ruhe (0–10)
• Schmerz beim Verbandwechsel (0–10)
• Schmerzcharakter (brennend, stechend, dumpf)]

Infektionsstatus & Biofilm-Bewertung:

[Kritische Kolonisierung vs. Lokale Infektion vs. Systemische Infektion nach ICW/IWII-Kriterien erfassen: Biofilmbelag, Belagsbildung trotz Spülung, Rötung, Überwärmung, Schmerzannahme, Eiterbildung, Systemzeichen (Fieber, CRP/BSG, Phlegmone). Wichtig: Keine systemische Antibiose ohne systemische Infektionszeichen!]

4. THERAPIEPLANUNG NACH DEM TIME- / M.O.I.S.T.-PRINZIP

Kausaltherapie (Ursachenbehandlung): <i>[Hier exakt festlegen: z. B. Kompressionstherapie (Pütter-Kurzzugbinden in Entstauungsphase ca. 40 mmHg; nach Entstauung Zweikomponenten-Ulkusstrumpfsystem KKL III). Bei Dekubitus: Druckentlastungs- & Lagerungsplan (z.B. Wechseldrucksystem, 30°-Lagerung). Bei DFS: Druckentlastungsschuh]</i>	T — Tissue (Wundreinigung / Débridement): <i>[Hier Methode & Wundspüllösung festlegen: Wundspülung mit Ringer- / Polyhexanid- / Octenidin-Lösung (Einwirkzeit 10–15 Min. bei Biofilm). Mechanisches Débridement (z. B. Debrisoft®-Monofilamentpad), autolytisches Débridement (Hydrogel) oder Enzymatisch. Hinweis: Scharfes Skalpell-Débridement = Arztvorbehalt!]</i>
I — Infection / Inflammation (Antiseptik): <i>[Hier festlegen: Antiseptischer Wundverband bei Infektrisiko / Biofilm (z. B. silberhaltige Wundauflage, Polyhexanid-Kompresse). Indikation & Tragedauer definieren]</i>	M — Moisture (Exsudatmanagement): <i>[Hier Primärverband zur Feuchtigkeitsregulierung wählen: Hydrofaser (Aquacel®), Alginat oder Schaumstoffverband (Mepilex®). Sekundärverband & Fixierung festlegen. Verbandwechselintervall angeben (z. B. 3x wöchentlich)]</i>
E — Edge / Wundumgebung (Randschutz): <i>[Hier Wundrandschutz & Hautpflege festlegen: Filmformender Acrylat-Hautschutz (Cavilon®), Zinksalbe oder Fettgaze. Pflege der trockenen Wundumgebung mit Lanolin-freier Emulsion]</i>	Begleitende Schmerztherapie (DNQP): <i>[Hier erfassen: Schmerzmitteleinnahme nach WHO-Stufenschema in Absprache mit dem Arzt (z. B. Metamizol/Paracetamol 30 Min. VOR Verbandwechsel). Einsatz atraumatischer Silikon-Wundauflagen zur Vermeidung von Wechsel-Traumata]</i>

5. TABELLARISCHE VERLAUFSKONTROLLE & EVALUATION (WOCHE 1 BIS WOCHE 8)

Zeitpunkt	Wundmaße & Fläche	Wundgrund (%)	Exsudat & Wundrand	Schmerz (Ruhe/VW)	Angewendete Kausal- & Lokalthherapie	Evaluation / Anpassung
Woche 1 (Initial)	<i>[z. B. 5,4 × 3,0 cm Fläche: 16,2 cm² Tiefe: 3 mm]</i>	<i>[z. B. 60% Fibrin, 35% Granulation, 5% Epithel]</i>	<i>[Stark serös, Wundrand mazeriert]</i>	<i>[NRS 6/10 Ruhe NRS 8/10 VW]</i>	<i>[Polyhexanid-Einwirkung, Debrisoft, Hydrofaser, Pütter-Kompression]</i>	<i>[Initialbefund & Kausalstart]</i>
Woche 2 (Verlauf)	<i>[Maße eintragen, Fläche berechnen]</i>	<i>[% Nekrose/Fibrin/Granulation]</i>	<i>[Exsudatmenge & Randzustand]</i>	<i>[NRS Ruhe / NRS VW]</i>	<i>[Verbandsstoff & Kompressionskontrolle]</i>	<i>[Evaluation Reinigungseffekt]</i>
Woche 4 (Verlauf)	<i>[Maße eintragen, Fläche berechnen]</i>	<i>[% Fibrin/Granulation/ Epithel]</i>	<i>[Exsudatmenge & Randzustand]</i>	<i>[NRS Ruhe / NRS VW]</i>	<i>[ggf. Wechsel von Pütter auf Ulkus-Strumpf]</i>	<i>[Evaluation Entstauung & Granulation]</i>
Woche 6 (Verlauf)	<i>[Maße eintragen, Fläche berechnen]</i>	<i>[% Granulation / % Epithel]</i>	<i>[Leichtes Exsudat, Rand reizlos]</i>	<i>[NRS Ruhe / NRS VW]</i>	<i>[Anpassung Sekundärverband]</i>	<i>[Evaluation Epithelisierung]</i>
Woche 8 (Abschluss)	<i>[Maße eintragen, z. B. 0,4 cm²]</i>	<i>[100% Epithel / Nahezu geschlossen]</i>	<i>[Exsudatfrei, Rand intakt]</i>	<i>[NRS 0/10 Ruhe NRS 0/10 VW]</i>	<i>[Erhaltungskompression KKL II / III & Hautpflege]</i>	<i>[Abschlussevaluation & Remission (%)]</i>

6. EDUKATION, SCHNITTSTELLENMANAGEMENT & KRITISCHE REFLEXION

Patienten- & Angehörigenedukation (DNQP-Standard):

[Schulungsinhalte dokumentieren: Anleitung zur Aktivierung der Wadenmuskelpumpe (Fuß-Großzehenheber-Übungen), Entstauungslagerung der Beine, Hautpflege mit Lanolin-freien Emulsionen, Ernährungsberatung (Eiweiß/Zink/Vitamine), Adhärenzförderung bezüglich Kompression]

Interprofessionelles Schnittstellenmanagement:

[Zusammenarbeit reflektieren: Abstimmung der Kausaltherapie mit Hausarzt / Gefäßchirurg, Rezeptierung der modernen Verbandstoffe, Koordination mit Sanitätshaus (Strumpfanpassung) und ambulantem Pflegedienst]

Kritische Reflexion des Behandlungsverlaufs (Teil 3 der Hausarbeit):

[Analyse & Auswertung des Falls im Abgleich mit Leitlinien: Warum war die bisherige Therapie nicht erfolgreich (z. B. fehlende Kompression)? Welches war der entscheidende Wendepunkt (z.B. ABI-Messung & Kausalbehandlung)? Welche Hürden traten auf (z. B. Kompressions-Compliance, Schmerzen) und wie wurden sie gelöst? Welche Erkenntnisse ziehen Sie für Ihre zukünftige pflegerische Wundpraxis?]

7. FORMELLE PRÜFUNGS-CHECKLISTE & ABGABE-NACHWEISE

[]	Offizielles ICW®-Deckblatt: Offizielle Druckvorlage verwendet, alle Felder (Kursteilnehmer, Hospitationsstelle, Datum, Kurs-Nr.) ausgefüllt.
[]	Strukturierte Wundbeschreibung: Vollständige Anamnese, Wundlokalisierung, Wundmaße, M.O.I.S.T.-Raster, Schmerzerfassung (NRS) & Gefäßstatus (ABI).
[]	Therapieplanung & Kausalbehandlung: Begründung der Kausaltherapie (Kompression / Druckentlastung) & Lokalthherapie nach dem TIME-Prinzip.
[]	Kritische Reflexion (Teil 3): Pflegewissenschaftliche Reflexion des Verlaufs, Leitlinienabgleich (AWMF/DNQP) & Lerneffekte.
[]	Textumfang (Hauptteil): Hauptteil (Teil 1, 2, 3) umfasst EXAKT zwischen 5 und max. 8 DIN-A4-Seiten (Format: Arial 11pt / Times 12pt, 1,5-zeilig).
[]	Anhang A — Fotodokumentation: Datenschutzkonforme, zeitlich geordnete Vorher-Nachher-Wundfotos mit Maßstab/Wundlineal beigelegt.
[]	Anhang B — Hospitationsnachweis: Vollständig ausgefüllter & vom Wundzentrum/Arzt gestempelter Nachweis über die 16-stündige Hospitation.
[]	Anhang C — DSGVO & Eidesstattliche Erklärung: Vollständig unterschriebene Patienten-Einverständniserklärung sowie Eidesstattliche Erklärung des Hospitanten.

Datum, Ort: _____

Geprüft & Bestätigt: _____

Unterschrift Hospitant / Pflegefachmann

Stempel / Unterschrift Wundzentrum / Fachliche Leitung